

Université de Monastir

Faculté de Médecine de Monastir



Année universitaire 2024 / 2025

Préparation à l'Examen Classant National 2025

Questions d'évaluation

Sujet N° 21

DIARRHEE CHRONIQUE

Pr. Ag. Mohamed Hichem LOGHMARI

Service d'Hépatogastroentérologie

CHU Fattouma Bourguiba de Monastir

Séance du 04 Juillet 2025

Questions d'évaluation

Sujet n° 21 : DIARRHÉE CHRONIQUE

A. Epreuve QCM (48 questions)

1. La diarrhée est dite chronique, par définition, lorsqu'elle dépasse :

- A. Deux semaines
- B. Trois semaines
- C. Un mois
- D. Trois mois
- E. Six mois

2. Chez un patient rapportant la notion d'une diarrhée chronique, vous êtes orienté vers une fausse diarrhée chez le constipé devant :

- A. Présence de fécalome au toucher rectal
- B. Antécédents de diarrhée aiguë
- C. Emission glairo-sanglantes
- D. Alternance selles dures et liquides
- E. Matières hétérogènes

3. Devant une diarrhée chronique, les signes cliniques évocateurs d'un syndrome de malabsorption sont :

- A. Œdèmes des membres inférieurs
- B. Flush syndrome
- C. Acrodermatite
- D. Hypotension orthostatique
- E. Striation unguéale

4. Chez un patient présentant une diarrhée chronique, le bilan biologique à demander en première intention comporte :

- A. Numération et formule sanguine
- B. Dosage de l'élastase fécale
- C. Bilan phosphocalcique
- D. Albuminémie
- E. TSH

5. Chez un patient rapportant la notion d'une diarrhée chronique, vous évoquer plutôt une incontinence anale devant :

- A. Hypotonie du sphincter anal au toucher rectal
- B. Suintement anal en dehors de la défécation
- C. Besoin impérieux d'aller à la selle
- D. Incontinence urinaire associée
- E. Diarrhée matinale abondante

Réponses : **A, B, D**

6. Une diarrhée chronique de type sécrétoire vous fait évoquer :

- A. Vipome
- B. Choléra
- C. Maladie cœliaque
- D. Syndrome carcinoïde
- E. Hyperthyroïdie

7. Chez un patient présentant une diarrhée chronique, on évoque le mécanisme osmotique devant :

- A. Disparition au jeûne
- B. Présence d'un trou osmotique $> 125 \text{ mOsm/kg}$
- C. Diarrhée nocturne abondante
- D. Présence d'un laxatif non absorbé
- E. Syndrome de carence vitaminique

8. Devant une diarrhée chronique les éléments suivants sont en faveur d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) :

- A. Présence de glaires dans les selles
- B. Syndrome rectal
- C. Rectorragies
- D. Disparition de la diarrhée à l'épreuve de jeûne
- E. Fistules anales

9. Devant une diarrhée chronique les éléments en faveur d'un syndrome de l'intestin irritable sont :

- A. Douleur améliorée par la défécation
- B. Selles molles matinales
- C. Amaigrissement

- D. Absence d'anomalie biologique
- E. Incontinence fécale nocturne

10. Chez un patient présentant une diarrhée chronique vous évoquez une cause organique si vous constatez les éléments suivants :

- A. Association à un météorisme abdominal chronique
- B. Diarrhée à prédominance nocturne
- C. Association à des rectorragies minimales
- D. Association à une hypoalbuminémie
- E. Diarrhée liquidienne abondante

11. Devant une diarrhée chronique les éléments qui vous orientent vers une diarrhée motrice sont :

- A. Selles matinales
- B. Douleurs abdominales violentes
- C. Présence d'aliments non digérés dans les selles
- D. Amélioration par les ralentisseurs du transit
- E. Selles graisseuses

12. Dans le cadre de l'enquête étiologique, les éléments à rechercher systématiquement devant une diarrhée chronique sont :

- A. Prise d'AINS
- B. Séjour en zone tropicale
- C. Chirurgie du grêle
- D. Hypothyroïdie
- E. Radiothérapie pelvienne

13. Les éléments biologiques en faveur d'un syndrome de malabsorption chez un patient présentant une diarrhée chronique sont :

- A. Hypoalbuminémie
- B. Ferritinémie augmentée
- C. Hypocalcémie
- D. Carence en vitamine B12
- E. Hypokaliémie

14. Les éléments biologiques qui vous orientent vers une diarrhée chronique exsudative sont :

- A. Hypoglycémie
- B. Anémie
- C. Hypoalbuminémie
- D. Osmolarité fécale > 400 mOsm/kg
- E. Clairance de l' α 1-antitrypsine > 20 mL/j

15. Le(s) élément(s) qui permet(tent) de confirmer le diagnostic de maladie cœliaque chez l'adulte est(sont) :

- A. Atrophie villositaire sur biopsies du grêle.
- B. Anticorps anti-transglutaminase IgA positifs
- C. Aspect en mosaïque de la muqueuse duodénale
- D. Association à une maladie auto-immune.
- E. Mise en évidence de polynucléaires neutrophiles dans les selles

16. Devant une diarrhée chronique, le bilan de retentissement clinique comporte la recherche systématique de :

- A. Signes de déshydratation
- B. Œdèmes des membres inférieurs
- C. Flush syndrome
- D. Crises de tétanie
- E. Hémiplégie

17. En cas de diarrhée chronique vous évoquez une giardiose devant les éléments suivants :

- A. Notion de consommation de végétaux crus
- B. Notion d'un voyage récent en Afrique tropicale
- C. Diarrhée glairo-sanglante
- D. Atrophie villositaire aux biopsies du grêle.
- E. Fièvre en plateau

18. Une diarrhée chronique secondaire à une colonisation bactérienne chronique du grêle se voit dans les situations suivantes :

- A. Achlorhydrie gastrique
- B. Déficit immunitaire commun variable
- C. Oesophagectomie
- D. Neuropathie diabétique
- E. Pancréatite chronique

19. Devant une diarrhée chronique motrice on évoque les étiologies suivantes :

- A. Hyperthyroïdie
- B. Vagotomie tronculaire
- C. Syndrome de l'intestin irritable
- D. Syndrome de Zollinger-Ellison
- E. Cancer médullaire de la thyroïde

20. Chez un patient présentant une diarrhée chronique les critères diagnostiques en faveur du syndrome de l'intestin irritable sont :

- A. Douleurs abdominales liées à la défécation
- B. Amaigrissement
- C. Modifications de la consistance des selles
- D. Survenue des symptômes depuis au moins 6 mois
- E. Aspect glaireux des selles

21. Devant une diarrhée chronique osmotique est évoquée devant les éléments suivants :

- A. Diarrhée qui cède au jeûne
- B. Aspect graisseux des selles
- C. Absence d'amaigrissement
- D. Hypoalbuminémie
- E. Trouble osmotique $> 125 \text{ mOsm/kg}$

22. Les médicaments suivants peuvent entraîner une diarrhée chronique sécrétoire :

- A. Biguanides
- B. Laxatifs irritants
- C. Inhibiteurs de la pompe à protons
- D. Colchicine
- E. Amoxicilline

23. Une diarrhée chronique d'allure sécrétoire sans lésions macroscopiques à l'endoscopie vous fait évoquer :

- A. Colite lymphocytaire
- B. Colite collagène
- C. Maladie de Crohn
- D. Cryptosporidiose
- E. Vipome

24. Les complications de la maladie cœliaque sont :

- A. Lymphome de type T
- B. Ostéopénie
- C. Cholangite biliaire primitive
- D. Cavitation ganglionnaire
- E. Hypothyroïdie

25. Chez un patient présentant une diarrhée chronique vous êtes orientés vers la maladie de Whipple si vous constatez :

- A. Fièvre
- B. Arthralgies d'évolution capricieuse
- C. Polyadénomégalie
- D. Aphtes buccaux
- E. Erythème noueux

26. Sur des biopsies duodénales, faites chez un patient présentant une diarrhée chronique, vous retenez le diagnostic d'une maladie cœliaque devant les signes suivants :

- A. Atrophie villositaire
- B. Infiltrat de polynucléaires neutrophiles
- C. Hyperplasie des cryptes
- D. Lymphocytes intra-épithéliaux augmentés
- E. Granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires

27. Les signes biologiques en faveur d'une diarrhée chronique par malabsorption sont :

- A. Anémie ferriprive
- B. Hyponatrémie
- C. Hypocalcémie
- D. Augmentation des phosphatases alcalines
- E. Hypoalbuminémie

28. Chez un patient qui consulte pour une diarrhée chronique, vous évoquez une carence en vitamine B12 devant :

- A. Anémie macrocytaire
- B. Glossite
- C. Neuropathie périphérique
- D. Koilonychie
- E. Syndrome médullaire

29. Chez un enfant ayant une diarrhée chronique avec une cassure pondérale vous évoquer en premier l'étiologie suivante :

- A. Syndrome de l'intestin irritable
- B. Maladie cœliaque
- C. Intolérance au lactose
- D. Intolérance au gluten
- E. Giardiase

30. Devant une diarrhée chronique, vous êtes orienté vers le diagnostic d'une rectocolite hémorragique devant les aspects endoscopiques suivants :

- A. Atteinte rectale constante
- B. Lésions discontinues
- C. Atteinte du grêle fréquente
- D. Arrêt brusque des lésions en cas d'atteinte localisée
- E. Saignement au contact en endoscopie (fragilité muqueuse)

31. Devant une diarrhée chronique, vous êtes orienté vers le diagnostic d'une maladie de Crohn devant les éléments suivants :

- A. Fistules ano-périnéales
- B. Atteinte de l'intestin grêle
- C. Syndrome inflammatoire biologique
- D. Granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires
- E. Infiltrat lymphoplasmocytaire transmural

32. Le mécanisme le plus probable d'une diarrhée chronique survenant après une cholécystectomie est :

- A. Infection
- B. Hypersécrétion gastrique
- C. Malabsorption des sels biliaires
- D. Hypomotilité colique
- E. Insuffisance pancréatique

33. Devant une diarrhée chronique, vous évoquez le diagnostic d'un syndrome de Zollinger-Ellison devant les éléments suivants :

- A. Diarrhée sécrétoire abondante
- B. Signes de déshydratation
- C. Amélioration nette de la diarrhée sous inhibiteurs de la pompe à protons

- D. Anémie ferriprive
- E. Ulcères duodénaux multiples à l'endoscopie digestive haute

34. Devant une diarrhée chronique associée à une atrophie villositaire duodénale vous évoquez les étiologies suivantes :

- A. Sprue tropicale
- B. Entéropathie radique
- C. Giardiose
- D. Colonisation bactérienne chronique du grêle
- E. Maladie de Whipple

35. Devant une diarrhée chronique associée à un syndrome carcinoïde vous demandez les examens complémentaires suivants :

- A. Dosage des 5-HIAA urinaires
- B. Dosage de la chromogranine A
- C. Scanner thoraco-abdominal
- D. Octréoscan
- E. Dosage de la calcitonine

36. Devant une diarrhée chronique vous évoquez une pathologie organique si vous trouvez :

- A. Des rectorragies
- B. Un amaigrissement
- C. Un ballonnement abdominal persistant
- D. Une fièvre
- E. Une diarrhée à prédominance nocturne

37. Concernant le test au D-xylose utilisé dans l'exploration d'une diarrhée chronique :

- A. Il explore l'absorption des glucides
- B. Il est spécifique de l'insuffisance pancréatique
- C. Il peut être faussement normal en cas d'atteinte iléale
- D. Il est utile pour la diagnostic de la maladie coeliaque
- E. Un taux de xylosémie à 1h < 250 mg/L signifie une malabsorption.

38. Devant une diarrhée chronique vous évoquez une insuffisance pancréatique exocrine si vous constatez les éléments suivants :

- A. Diarrhée de type motrice
- B. Fièvre avec sueurs nocturnes

- C. Anémie ferriprive
- D. Stéatorrhée à 10 g/24 h
- E. Calcifications pancréatiques à l'IRM.

39. Vous évoquez la nature sécrétoire d'une diarrhée chronique devant :

- A. Persistance de la diarrhée malgré le jeûne
- B. Diarrhée volumineuse
- C. Douleurs abdominales calmées par la défécation
- D. Test au rouge carmin positif
- E. Osmolarité fécale basse

40. Une diarrhée fonctionnelle en rapport avec un syndrome de l'intestin irritable est retenue devant la normalité des explorations suivantes :

- A. NFS
- B. CRP
- C. Coloscopie
- D. Elastase fécale
- E. Test au rouge carmin

41. Une diarrhée chronique associée à une anémie ferriprive vous fait évoquer :

- A. Maladie cœliaque
- B. Maladie de Crohn
- C. Tumeur colique
- D. Pancréatite chronique
- E. Giardiase

42. Chez un patient qui se présent avec une diarrhée chronique vous évoquez une maladie inflammatoire intestinale devant :

- A. Une osmolarité fécale élevée
- B. Un taux élevé de la CRP
- C. Un test respiratoire au glucose positif
- D. Un taux élevé de la calprotectine fécale
- E. Un test au rouge carmin positif

43. Devant une diarrhée chronique vous devez rechercher en première intention les troubles métaboliques suivants :

- A. Insuffisance rénale
- B. Hypokaliémie
- C. Hypoglycémie
- D. Hypercalcémie
- E. Hypomagnésémie

44. Les signes cliniques de sévérité à rechercher systématiquement chez un patient présentant une diarrhée chronique sont :

- A. Signes de déshydratation
- B. Troubles neurologiques
- C. Hypotension artérielle
- D. Dermatose
- E. Présence de glaire dans les selles

45. Chez un patient qui a développé une diarrhée chronique dans les suites d'une radiothérapie pour cancer de la prostate, vous évoquez le(s) mécanisme(s) suivant(s) à l'origine de cette diarrhée :

- A. Osmotique
- B. Motrice
- C. Sécrétoire
- D. Exsudative
- E. Post-infectieuse

46. Chez un patient qui présente une diarrhée chronique, l'absence de lésions macroscopiques aux explorations endoscopiques vous fait évoquer :

- A. Recto-colite hémorragique
- B. Colite lymphocytaire
- C. Colite collagène
- D. Vipome
- E. Syndrome de l'intestin irritable

47. Chez un patient qui consulte pour une diarrhée chronique, vous retenez en faveur d'une diarrhée exsudative :

- A- La présence de selles graisseuses.
- B- L'amélioration de la diarrhée par le jeûne.

- C- Une stéatorrhée.
- D- Un test au rouge carmin positif.
- E- Une hypoalbuminémie

B. Epreuve cas cliniques (26 questions)

a- Cas clinique n°1 :

Mme Zaineb L. âgée de 62 ans aux antécédents de troubles anxieux, consulte pour une diarrhée liquidienne évoluant depuis 4 mois associée à des douleurs abdominales diffuses à type de spasmes, une insomnie, des palpitations et une perte de poids de 2 kg. Cette symptomatologie survient essentiellement le matin, en post prandial et est nettement améliorée lorsque la patiente est en vacances.

A l'examen clinique : Bon état général, IMC = 22 Kg/m², des conjonctives normo-colorées et l'examen abdominal est normal. L'examen parasitologique des selles est négatif.

1) Quels sont les deux diagnostics que vous évoquez en premier devant ce tableau ?

- A- Maladie de Crohn
- B- Cancer colorectal
- C- Hyperthyroïdie
- D- Maladie cœliaque
- E- Troubles fonctionnels intestinaux.

2) Vos proposez pour cette patiente :

- A- Une coloscopie
- B- Un bilan thyroïdien
- C- Un entéro-scanner
- D- Une entéro-IRM
- E- Aucune exploration n'est indiquée à ce stade

b- Cas clinique n°2 :

Une femme de 25 ans consulte pour une diarrhée chronique liquidienne évoluant depuis 8 mois avec amaigrissement de 4 kg en 6 mois. Une endoscopie digestive haute lui a été réalisée avec des biopsies duodénales. L'examen microscopique montre l'absence de villosités duodénales, une augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux et une hyperplasie des cryptes.

A la biologie on trouve : Hb = 9.4 g/dL, VGM = 73, GR = 2 500 000/mm³, Reticulocytes = 1% ; GB = 4900/mm³ ; Plq = 430 000/mm³, CRP = 4 mg/L.

1) Vous retenez comme diagnostic chez cette patiente :

- A- Maladie de Crohn
- B- Lymphome duodénal
- C- Maladie de Whipple
- D- Maladie cœliaque
- E- Sprue tropicale

2) Le mécanisme étiopathogénique de la diarrhée constatée chez cette patiente serait :

- A- Diarrhée sécrétoire
- B- Diarrhée exsudative
- C- Diarrhée par malabsorption
- D- Diarrhée motrice
- E- Diarrhée fonctionnelle

3) L'origine la plus probable de l'anémie présentée par cette patiente serait :

- A- Carence en vitamine B12
- B- Carence martiale
- C- Carence en folates
- D- Hémolyse
- E- Inflammatoire

c- Cas clinique n°3 :

Patient âgé de 62 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour une diarrhée faite de 5 selles glairo-sanglantes par jour avec un syndrome rectal évoluant depuis 2 mois. A l'examen physique : T° : 37°, pouls : 80 bpm, abdomen souple et indolore, fissure anale latérale (à 9h en position genu-pectoral). À la biologie : CRP = 40 mg/L, GB = 7000 /mm³, Hb = 10.1 g/dL, albumine = 27 g/L. L'examen parasitologique des selles est négatif. A la coloscopie : le rectum et le colon sont diffusément atteints sans intervalle de muqueuse saine ; la muqueuse est congestive, granitée, très saignante au contact, siège de quelques ulcérations superficielles de taille variable. L'iléon est normal. Les biopsies coliques ont objectivé des ulcérations limitées à la muqueuse associées à un infiltrat inflammatoire du chorion et à des abcès cryptiques. Le diagnostic de RCH est évoqué.

1) Le mécanisme le plus plausible de la diarrhée constatée chez ce patient :

- A- Diarrhée sécrétoire
- B- Diarrhée exsudative
- C- Diarrhée par malabsorption
- D- Diarrhée motrice
- E- Diarrhée fonctionnelle

2) Vous retenir en faveur du diagnostic de RCH chez ce patient :

- A- Lésions endoscopiques sans intervalle de muqueuse saine
- B- Muqueuse très saignante au contact (fragilité).
- C- Iléon normal
- D- Ulcérations limitées à la muqueuse à l'histologie.
- E- Diarrhée exsudative.

3) Le(s) élément(s) qui vous font évoquer l'hypothèse d'une maladie de Crohn chez ce patient est(sont) :

- A- Age avancé
- B- Syndrome rectal
- C- Abscès cryptiques
- D- Fissure anale latérale
- E- Hypoalbuminémie

d- Cas clinique n°4 :

Patiente âgée de 28 ans, sans antécédents personnels ou familiaux notables, consulte pour une diarrhée intermittente évoluant depuis 2 ans faite de 4 à 5 selles /24h, liquidienne, non sanglante, diurne, impérieuse, post prandiale précoce et contenant des aliments non digérés. L'interrogatoire trouve la notion de douleurs abdominales modérées des deux flancs avec un ballonnement abdominal. A noter l'absence de prise médicamenteuse et l'absence d'amaigrissement. L'examen clinique est sans particularités. La NFS et la CRP étaient normales.

1) Le mécanisme le plus probable de cette diarrhée serait :

- A- Diarrhée sécrétoire
- B- Diarrhée exsudative
- C- Diarrhée par malabsorption
- D- Diarrhée motrice
- E- Diarrhée fonctionnelle

2) Le diagnostic que vous évoquez en premier chez cette patiente est :

- A- Maladie de Crohn
- B- Cancer colorectal
- C- Lymphome intestinal
- D- Maladie cœliaque
- E- Trouble fonctionnel intestinal.

3) Vos proposez pour cette patiente à ce stade :

- A- Une coloscopie
- B- Une échographie abdominale
- C- Un entéro-scanner
- D- Une entéro-IRM
- E- Aucune exploration n'est indiquée.

e- Cas clinique n°5 :

Patiente âgée de 30 ans, d'origine rurale, consulte pour une diarrhée faite de 3 à 4 selles liquidiennes par jour associée à des douleurs de la fosse iliaque droite évoluant depuis 3 mois et à un amaigrissement de 3 Kg. L'examen physique trouve une température à 37°C et une sensibilité de la fosse iliaque droite. Le bilan biologique : Hb= 9g/dL, VGM = 78, TCMH = 25, réticulocytes = 50 000/mm³ ; GB = 5600/mm³, plaquettes = 520 000 / mm³ ; CRP = 55 mg/L.

L'échographie abdominale a montré un épaississement du carrefour iléo-caecal.

Le diagnostic de maladie de Crohn iléo-caecale est évoqué.

1) Les deux principaux diagnostics différentiels à évoquer devant ce tableau sont :

- A- Tuberculose intestinale
- B- Iléite infectieuse à salmonelles
- C- Lymphome intestinal
- D- Maladie cœliaque
- E- Trouble fonctionnel intestinal.

2) Le premier examen complémentaire à demander pour étayer le diagnostic est :

- A- Une entéro-IRM.
- B- Une recherche de BK dans les crachats.
- C- Un entéro-scanner
- D- Une iléo-coloscopie
- E- Une intradermoréaction à la tuberculine (IDR)

3) Le(s) mécanisme(s) de l'anémie constatée chez cette patiente est(sont) :

- A- Carence en vitamine B12
- B- Carence martiale
- C- Carence en folates
- D- Hémolyse
- E- Inflammatoire

f- Cas clinique n°6 :

Mme Salha A., âgée de 28 ans, aux antécédents de diabète de type 1 sous insuline, est hospitalisée pour une diarrhée liquidienne à raison de 5 à 7 selles/ jour évoluant depuis 4 mois associée à une asthénie et à un amaigrissement de 3 Kg. L'examen physique montre une pâleur cutanéomuqueuse sans autres anomalies. Le bilan biologique montre : Hémoglobine = 9,5 g/dl ; VGM = 73 μ 3 ; GB = 5200/ mm3 ; plaquettes = 500 000/mm3 , Na+= 142 mmol/L ; K+ = 3 mmol/L, Urée = 10 mmol/L ; Créatininémie = 124 μ mol/L, Albuminémie = 28 g/L. Ferritinémie = 8 μ g/L

Une maladie cœliaque est évoquée.

1) Les éléments qui vous orientent vers une maladie cœliaque chez cette patiente sont :

- A- ATCDS de diabète type 1
- B- Anémie ferriprive
- C- Hypokaliémie
- D- Insuffisance rénale
- E- Hypoalbuminémie

2) L'examen à pratiquer en première intention pour confirmer ce diagnostic est :

- A- Une entéro-IRM.
- B- Dosage des anticorps de la maladie cœliaque
- C- Un entéro-scanner
- D- Une endoscopie digestive haute avec biopsies
- E- Fécalogramme

g- Cas clinique n°7 :

Mme Asma T., âgée de 33 ans est hospitalisée pour diarrhée liquidienne 4 à 5 selles /jour évoluant depuis 9 mois associée à un amaigrissement chiffré de 10 Kg en 1 an. A l'examen on note une pâleur cutanée, des cheveux cassants avec des œdèmes des membres inférieurs de type rénal.

Au bilan biologique : Hb = 9,5 g/dL ; VGM = 106 μ^3 ; Albuminémie = 28 g/L ; TP = 62%, facteur V = 80% ; Na⁺ = 138 mmol/L, K⁺ = 3,1 mmol/L, glycémie = 3 mmol/L

La maladie cœliaque est évoquée. Une FOGD avec des biopsies duodénales ont été réalisées.

1) Les éléments cliniques en faveur d'un syndrome de malabsorption intestinale chez cette patiente sont :

- A- Diarrhée liquidienne
- B- Amaigrissement
- C- Pâleur cutanéomuqueuse
- D- Cheveux cassants
- E- Œdèmes des membres inférieurs

2) Les éléments biologiques en faveur d'un syndrome de malabsorption intestinale chez cette patiente sont :

- A- Anémie macrocytaire
- B- Hypokaliémie
- C- Hypoalbuminémie
- D- Hypoglycémie
- E- TP bas

3) Les deux lésions histologiques, à rechercher sur les biopsies duodénales, susceptibles de confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque chez cette patiente sont :

- A- Granulomes épithélioïdes sans nécrose caséuse
- B- Atrophie villositaire totale ou subtotale
- C- Infiltrat inflammatoire riche en plasmocytes
- D- Augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux.
- E- Abscès cryptiques.

4) Une surveillance régulière par une endoscopie digestive haute est indiquée chez cette patiente à la recherche d'une complication redoutable, laquelle ?

- A- Adénocarcinome duodéal
- B- Cavitation ganglionnaire
- C- Lymphome duodéal
- D- Sprue réfractaire
- E- Ulcérations jéjunales

h- Cas clinique n°8 :

Une patiente âgée de 30 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour une diarrhée faite de 6 selles /24h diurnes et nocturnes, luisantes et collant à la cuvette, avec douleurs de la fosse iliaque droite évoluant depuis 7 mois, associée à une anorexie et un amaigrissement de 3 kg en 3 mois. Il n'y a pas de notion de prise médicamenteuse. A l'examen physique, la patiente est pale, les ongles sont mous et cassants, signe de Chvostek est positif. Le reste de l'examen physique est sans particularités. A la biologie Hb = 9g/dL, VGM = $70\mu^3$, TCMH = 25pg, réticulocytes = $30\,000/m^3$; plaquette = $120\,000/mm^3$, CRP = 5 mg/L, Albumine = 30g/L ; calcémie = 2 mmol/L ; cholestérolémie = 3 mmol/L (N = 3,8 à 5,2) ; ferritinémie = 10 $\mu g/L$.

1) Chez cette patiente les éléments qui vous permettent de retenir le diagnostic d'une diarrhée chronique sont :

- A- Une diarrhée > 2 selles /j
- B- Une diarrhée > 3 selles /j
- C- Une durée de la diarrhée > 7 jours
- D- Une durée de la diarrhée > 1 mois
- E- Une durée de la diarrhée > 6 mois

2) Les éléments en faveur d'une diarrhée par malabsorption chez cette patiente sont :

- A- Signe de Chvostek
- B- Thrombopénie
- C- Hypoalbuminémie
- D- Ongles mous et cassants
- E- Hypcholestérolémie.

3) Le premier examen complémentaire à visée étiologique que vous demanderiez chez cette patiente est :

- A- Une entéro-IRM.
- B- Un dosage des anticorps de la maladie cœliaque
- C- Une iléo-coloscopie avec biopsies iléales et coliques
- D- Une endoscopie digestive haute avec biopsies duodénales
- E- Un dosage de la calprotectine fécale

i- Cas clinique n°9 :

Une patiente âgée de 30 ans, sans antécédents pathologiques, se plaint depuis 3 ans de douleurs abdominales récurrentes, soulagées par l'émission des gaz et associées à une diarrhée liquidienne, faite de 5 selles/24 heures, diurne, postprandiale précoce, impérieuse et contenant des aliments non digérés. Pas de notion d'amaigrissement. Pas de notion de prise médicamenteuse. L'examen physique est normal.

1) Le mécanisme principal de la diarrhée chez cette patiente est :

- A- Une diarrhée exsudative
- B- Une diarrhée sécrétoire
- C- Une diarrhée osmotique
- D- Une diarrhée motrice
- E- Une diarrhée par malabsorption

2) Les éléments en faveur du diagnostic de troubles fonctionnels intestinaux chez cette patiente sont :

- A- La chronicité des symptômes
- B- L'âge jeune
- C- L'absence d'amaigrissement
- D- Le nombre faible de selles par jours
- E- L'horaire diurne des symptômes.

3) La patiente vous a consulté un an plus tard avec une diarrhée liquidienne associée à des épisodes de constipation évoluant depuis 2 mois. Vous proposez en premier chez cette patiente :

- A- Un entéroscanner
- B- Une coloscopie
- C- Un bilan de malabsorption
- D- Un bilan thyroïdien
- E- Un traitement symptomatique sans aucune exploration complémentaire.

Fin de l'évaluation

Bonne chance